

TEMA 7.3 • NEFROLOGÍA

Insuficiencia Renal Aguda

PERFIL EUNACOM 1.06.1.003

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

IRC — Manejo de Hipertensión e Hipervolemia

Fisiopatología

↓ Filtración Glomerular → **Retención de sodio y agua** → Hipervolemia → **HTA y/o Edema pulmonar agudo**.

Objetivos del Tratamiento en IRC

TABLA 7.3.1: PARÁMETRO VS OBJETIVO EN IRC	
PARÁMETRO	OBJETIVO EN IRC
Presión arterial	< 130/80 mmHg siempre (sin tolerancia a 140/90)
Volemia	Restricción hidrosalina

> El umbral diagnóstico de HTA es 130/80 mmHg (actualización actual), pero **en IRC el objetivo de manejo es siempre < 130/80**.

Tratamiento

TABLA 7.3.2: MEDIDA VS DETALLE	
MEDIDA	DETALLE
Restricción hidrosalina	Pilar del tratamiento (↓ ingesta de agua y sodio)
Diuréticos	Furosemida (ayuda a excretar sodio y agua). Usar con precaución.
IECA / ARA-II (yeka/arados)	Indicados por su efecto nefroprotector (↓ proteinuria). También útiles si HTA.

Riesgos de los Diuréticos en IRC

TABLA 7.3.3: RIESGO VS MECANISMO	
RIESGO	MECANISMO
IRA prerrenal sobreagregada	Hipovolemia por exceso de diuresis → ↑ creatinina
Empeoramiento de hiponatremia	La IRC ya tiende a hiponatremia

EUNACOM CRITERIOS

Si un paciente con IRC en tratamiento con diurético sube la creatinina → **sospechar IRA prerrenal por diurético** antes de cualquier otra causa.

Edema Pulmonar Agudo en IRC

- La furosemida tiene un rol **especialmente relevante** (a diferencia del EPA por falla cardíaca pura donde se priorizan vasodilatadores).
- Causa: **Hipervolemia** + falla cardíaca → furosemida + vasodilatadores (nitroprusiato).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 70 años con antecedente de insuficiencia cardíaca descompensada presenta creatinina de 2.8 mg/dL. El sodio urinario es de 8 mEq/L y el FeNa es de 0.5%. ¿Cuál es el tipo de insuficiencia renal aguda más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Insuficiencia Renal Aguda. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Transcripción con error técnico - contenido parcialmente reconstituido del contexto de otras clases.
- IRA prerrenal: causa más frecuente, por hipoperfusión renal. FeNa menor al 1%, Na urinario menor a 20 mEq/L.
- IRA renal: daño directo del parénquima. Causa más frecuente: necrosis tubular aguda. FeNa mayor al 1%.
- IRA postrenal: obstrucción urinaria, se diagnostica con ecografía (hidronefrosis).
- El FeNa y el sodio urinario son clave para diferenciar prerrenal de renal.
- Las indicaciones de diálisis de urgencia aplican a IRA con complicaciones graves no respondedoras.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INSUFICIENCIA RENAL AGUDA)

PREGUNTA 1

Paciente de 70 años con antecedente de insuficiencia cardíaca descompensada presenta creatinina de 2.8 mg/dL. El sodio urinario es de 8 mEq/L y el FeNa es de 0.5%. ¿Cuál es el tipo de insuficiencia renal aguda más probable?

- ☐ A) IRA renal por necrosis tubular aguda
- ☐ B) IRA prerrenal
- ☐ C) IRA postrenal obstructiva
- ☐ D) IRA renal por glomerulonefritis
- ☐ E) Insuficiencia renal crónica reagudizada

PREGUNTA 2

¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda de tipo renal (intrínseca)?

- ☐ A) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
- ☐ B) Nefritis intersticial por fármacos
- ☐ C) Necrosis tubular aguda
- ☐ D) Síndrome hemolítico urémico
- ☐ E) Obstrucción ureteral bilateral

PREGUNTA 3

En un paciente con insuficiencia renal aguda, ¿cuál es el examen de elección para descartar una causa postrenal?

- ☐ A) Sedimento urinario
- ☐ B) FeNa (fracción excretada de sodio)
- ☐ C) Ecografía renal y de vías urinarias
- ☐ D) Biopsia renal
- ☐ E) Hemograma completo

RESUMEN: INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

Nota: La transcripción de esta clase presenta un error técnico (audio no capturado correctamente). El contenido esperado cubre la clasificación de la insuficiencia renal aguda en prerrenal, renal y postrenal, sus causas principales y el enfoque diagnóstico inicial. La insuficiencia renal aguda prerrenal es la más frecuente y se debe a disminución de la perfusión renal (hipovolemia, shock, insuficiencia cardíaca). La renal incluye necrosis tubular aguda, glomerulonefritis y nefritis intersticial. La postrenal se debe a obstrucción del tracto urinario. El estudio inicial incluye ecografía renal, sedimento urinario, electrolitos urinarios (FeNa y sodio urinario) para diferenciar prerrenal de renal. En la prerrenal el FeNa es menor al 1% y el sodio urinario menor a 20 mEq/L.